

Hasil Requirement

Jumlah kader ada 5 orang
List kunjungan anak di data sementara dalam map (1 Map untuk 1 KK)
Map adalah data hasil imunisasi anak per KK (1 orang tua = 1 map), diisi oleh kader pada saat imunisasi. Setelah imunisasi, data akan di entry oleh bindes kedalam Buku KIA dan aplikasi sebagai laporan ke Puskesmas.
Layanan imunisasi terbagi dalam 4 layanan, yaitu 1. Melakukan pendaftaran (ambil nomor antrian dan map) 2. Melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan. 3. Menerima layanan Vaksinasi (suntik) 4. Layanan penyuluhan atau edukasi atau konseling. Pada layanan ini, anak atau ibu hamil akan memberikan keluhan yang dirasakan dan bila diperlukan obat, maka layanan ini juga yang memberikan resep obat nya.
Layanan Vaksinasi dilakukan oleh bidan dari Puskesmas
Jumlah keguguran tergolong minim
Jumlah wajib periksa ada 4 kali yaitu 2 kali ke dokter untuk melakukan USG secara gratis pada usia kandungan 3 bulan dan 8 bulan serta 4 kali ke posyandu.
Proses layanan imunisasi untuk ibu hamil adalah Layanan pendaftaran lalu timbang/ukur dan terakhir pada layanan penyuluhan/konseling
Jumlah ibu hamil saat ini ada 6 orang
Ketika ibu hamil ingin melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis, harus melalui posyandu dahulu dan membawa buku KIA
Ketidaktahuan gender bayi biasanya sudah diketahui
Buku KIA harus diminta dari dokter yang ada di puskesmas lalu dibawa ke bidan. Data ibu hamil pada buku KIA biasanya dimulai saat usia kehamilan 3 bulan
Layanan ibu hamil di posyandu biasanya menerima mengukur berat badan dan lila, lalu bila diperlukan akan diberi vitamin dan lainnya
Ketika ibu lupa membawa buku KIA saat posyandu, maka pengisian data sementara dilakukan pada map
Syarat menjadi kader ada beberapa hal, yaitu orang lokal, memiliki loyalitas, mampu memahami proses yang ada, tidak ada batasan usia selama masih mampu membantu proses kegiatan di posyandu, tidak wajib orang yang sudah menikah

Ketika lupa jadwal, maka kader akan menelepon orang tua dan bahkan menjemput anak tersebut dari rumah. Namun ketika keluarga diluar kota, maka akan ditunda hingga imunisasi dibulan depannya
Anak yang sedang demam tidak akan menerima layanan vaksinasi hingga sembuh dan menerima layanan tersebut pada imunisasi selanjutnya.
Gejalanya akan disadari oleh kader dan bidan lalu data hasil pemeriksaan saat imunisasi akan diinput oleh bidan kedalam aplikasi dan akan dianalisis dan di putuskan oleh pihak puskesmas
PMT lokal diberikan untuk mencegah stunting atau kurang gizi dari usia anak o sampai 5 tahun
Tantangan yang ada yaitu kesadaran orang tua yang minim untuk datang ke imunisasi. Bila orang tua tidak datang, maka akan dijumpai ke rumah
Perhatian atau pendampingan khusus akan diberikan seperti pemberian PMT yang lebih intens dari posyandu, puskesmas, dinas kesehatan dan kantor keagamaan
Ibu nifas atau pasca melahirkan, akan menerima layanan kunjungan dari bidan desa sebanyak 2 sampai 4 kali (rentang usia bayi 0-3 bulan atau paling lama 6 bulan) tergantung pada kesehatan ibu atau anak
Ibu yang mengalami stress, biasanya terdapat beberapa indikator seperti H atau tekanan darah dan lainnya), akan didampingi oleh bidan desa
Vaksin yang diberikan oleh puskesmas adalah vaksin yang tersedia stok nya dan tetap diberikan dengan memperhatikan tabel pemberian vaksin yang ada di buku KIA
Imunisasi dilakukan 1 kali dalam 1 bulan

Analisa GenderMag berdasarkan Hasil Requirement

1. Motivations (Motivasi)

Facet ini melihat apakah pengguna menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas spesifik atau untuk eksplorasi.

- **Kebutuhan Informasi Spesifik:** Orang tua sering lupa jadwal, sehingga kader harus menelepon atau menjemput ke rumah. Ini menunjukkan motivasi utama mereka adalah pengingat jadwal yang sangat praktis agar tidak perlu didatangi kader.
- **Penyelesaian Masalah (Problem-Solving):** Pengguna (ibu hamil/orang tua) akan menggunakan aplikasi jika hal itu membantu mereka mendapatkan rujukan ke dokter spesialis atau memastikan stok vaksin tersedia di Puskesmas sebelum datang.

2. Information Processing Styles (Gaya Pemrosesan Informasi)

Apakah pengguna memproses informasi secara menyeluruh (komprehensif) atau langsung beraksi (selektif)?

- **Ketergantungan pada Dokumen Fisik:** Penggunaan Map per KK dan Buku KIA menunjukkan bahwa kader dan orang tua terbiasa dengan struktur data yang berurutan dan fisik. Aplikasi perlu menampilkan informasi yang sejalan dengan struktur Buku KIA agar mereka tidak bingung saat beralih ke digital.
- **Navigasi Layanan:** Layanan yang terbagi dalam 4 tahap (Pendaftaran → Timbang → Vaksin → Edukasi) menunjukkan alur kerja linier. Pengguna dengan gaya pemrosesan komprehensif akan membutuhkan visualisasi progres (misal: bilah kemajuan/stepper) untuk tahu mereka sedang di tahap mana.

3. Computer Self-Efficacy (Kepercayaan Diri terhadap Komputer)

Sejauh mana pengguna percaya diri dapat mengoperasikan sistem tanpa rasa takut salah.

- **Rasa Takut Salah (Low Efficacy):** Karena jika Buku KIA lupa dibawa, data diinput sementara di Map, aplikasi harus memiliki fitur sinkronisasi atau input darurat yang mudah agar kader tidak takut data hilang jika mereka lupa prosedur standar.
- **Variabel Kader:** Syarat kader yang tidak membatasi usia (selama mampu membantu) berarti aplikasi akan digunakan oleh berbagai rentang usia. Desain harus sangat intuitif dengan ikon yang jelas dan teks yang tidak teknis untuk mendukung kader yang mungkin memiliki *self-efficacy* rendah terhadap gadget baru.

4. Risk Aversion (Penghindaran Risiko)

Bagaimana pengguna bereaksi terhadap risiko saat mencoba fitur baru.

- **Risiko Kesehatan:** Anak demam tidak divaksin dan ditunda ke bulan depan. Aplikasi harus mampu menangani skenario "penundaan" ini tanpa merusak algoritma jadwal keseluruhan. Jika sistem kaku, pengguna akan takut (risk averse) menggunakannya saat terjadi kondisi medis yang tidak normal.
- **Keamanan Data:** Data hasil pemeriksaan diinput bidan ke aplikasi Puskesmas untuk dianalisis. Pengguna perlu diyakinkan bahwa input data mereka di aplikasi aman dan selaras dengan keputusan pihak Puskesmas agar tidak terjadi konflik informasi.

5. Styles of Learning Technology (Gaya Belajar Teknologi)

Apakah pengguna belajar melalui instruksi (tutorial) atau mencoba-coba (eksplorasi)?

- **Instruksi Terstruktur:** Karena proses imunisasi sangat diatur oleh tabel di Buku KIA dan aturan Puskesmas, pengguna kemungkinan besar adalah pelajar berbasis instruksi.
- **Kebutuhan Onboarding:** Aplikasi sebaiknya menyediakan panduan langkah-demi-langkah yang meniru proses di lapangan (misal: mulai dari pendaftaran hingga konseling) daripada membiarkan pengguna mengeksplorasi semua menu sekaligus.

Analisa GenderMag ke Peningkat atau Notifikasi

1. Motivations (Motivasi)

Facet ini berkaitan dengan alasan pengguna ingin berinteraksi dengan notifikasi.

- **Informasi Relevan:** Orang tua sering lupa jadwal hingga harus diingatkan/dijemput oleh kader.
- **Implementasi Notifikasi:** Notifikasi jangan hanya berisi teks "Ada Imunisasi", tetapi harus memberikan nilai tambah (motivasi) seperti: "Yuk ke Posyandu besok! Hadiah perlindungan & PMT lokal segar menanti si kecil ". Ini akan menarik minat orang tua yang memiliki kesadaran minim untuk datang.

2. Information Processing Styles (Gaya Pemrosesan Informasi)

Mempertimbangkan bagaimana pengguna menyerap pesan dalam notifikasi.

- **Informasi Relevan:** Layanan posyandu memiliki 4 tahap yang terstruktur (Pendaftaran, Timbang, Vaksin, Konseling).

- **Implementasi Notifikasi:**

- **Gaya Selektif:** Berikan notifikasi ringkas berisi: "Jadwal: Besok. Lokasi: Posyandu Mejan. Jam: 09.00".
- **Gaya Komprehensif:** Sediakan opsi untuk "Lihat Detail" yang menjelaskan bahwa besok akan ada layanan ke-3 (Vaksinasi) dan ke-4 (Konseling/Edukasi).

3. Computer Self-Efficacy (Kepercayaan Diri)

Bagaimana desain notifikasi membantu pengguna yang ragu dalam menggunakan teknologi.

- **Informasi Relevan:** Syarat kader tidak ada batasan usia, sehingga pengguna (kader/orang tua) memiliki variasi literasi digital.
- **Implementasi Notifikasi:** Gunakan bahasa yang sangat sederhana dan hindari istilah teknis medis yang rumit. Gunakan *Action Button* yang jelas pada notifikasi, seperti "Konfirmasi Kehadiran" atau "Ingatkan Nanti", untuk memberikan rasa kendali pada pengguna.

4. Risk Aversion (Penghindaran Risiko)

Memitigasi ketakutan pengguna jika ada kondisi medis yang tidak normal.

- **Informasi Relevan:** Anak demam tidak akan menerima vaksinasi. Stok vaksin di Puskesmas juga bergantung pada ketersediaan.
- **Implementasi Notifikasi:** Jika anak sedang demam, berikan fitur pada notifikasi untuk melaporkan kondisi tersebut ("Anak sedang demam"). Sistem *Rule-Based AI* kemudian harus mengirimkan notifikasi balasan otomatis: "Imunisasi ditunda ke bulan depan sesuai prosedur". Ini mengurangi kecemasan orang tua akan risiko kesehatan anak.

5. Styles of Learning Technology (Gaya Belajar Teknologi)

Mengarahkan pengguna melalui instruksi daripada eksplorasi mandiri.

- **Informasi Relevan:** Penggunaan Buku KIA dan Map per KK sangat prosedural.
- **Implementasi Notifikasi:** Notifikasi dapat berfungsi sebagai panduan langkah demi langkah. Contoh: "Langkah 1: Jangan lupa bawa Buku KIA besok" atau "Langkah 2: Jika Buku KIA hilang, data akan dicatat sementara di Map". Ini memberikan instruksi terstruktur yang disukai oleh profil pengguna tertentu